

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SELASA / 24 DESEMBER 2024
 PUKUL : 10.00-12.00 WIB
 JENIS MEETING : KOMITE MEDIK
 TEMPAT : *ZOOM MEETING* (LOKASI DINAS MASING-MASING)

Berikut hasil notulen :

1	Pokok Bahasan : Rujuk Internal
	Masalah : Konsul dan Rujuk Internal
	Keterangan : rawat jalan
	PIC : DPJP dan Karu Irja
	ilustrasi: Konsul Internal (1 episode) Periksa ke Dokter A Tgl 1 Des ➔ Periksa ke Dokter B Tgl 1 Des ➔ Kembali ke Dokter A Tgl 5 Des 1 episode Rujukan Internal (episode terpisah) Periksa ke Dokter A Tgl 1 Des ➔ Periksa ke Dokter B Tgl 1 Des ➔ Periksa ke Dokter B Tgl 5 Des episode 1 episode 2
	Rencana Tindak Lanjut Sebisa mungkin tidak merujuk internal, menyelesaikan poli utama hingga stabil terlebih dahulu. Apabila harus dirujuk internal, maka DPJP utama melakukan ITER / PRB. Kemudian dialihkan ke DPJP rujukan. Untuk rujuk internal fisioterapi, dilakukan setelah penyakit utama (DPJP utama) telah stabil.
2	Pokok Bahasan : Alih rawat
	Masalah : Pasien dengan 2 DPJP
	Keterangan : Cont.
	SURAT RUJUK INTERNAL No. RJIN24122200000006 Klinik Asal : Klinik Saraf Klinik Tujuan : Klinik Fisioterapi Nama Pasien : NOVY ACHDIATI No. RM : 131258 Tgl. Lahir : 23/11/1968 Umur: 56th 0bln 29hr No. Kartu BPJS : 0000111112492 Masa Berlaku Rujukan : 13/03/2025 Diagnosis Klinik Asal : Adhesive Capsulitis Terapi : LAFALOS CR 20 G - SANBE No. I S3dd1 -,Rute: Oral GABAPENTIN TAB 300 MG - HEXPHARM JAYA1/2 VALISANBE TAB 5 MG - SANBE1/2 PROFENAL TAB - YARINDO1/3 m.f. t.a. da in caps No. XXX S0-0-1 -,Rute: Oral NEUROMED TAB - PROMED No. II S2dd1 -,Rute: Oral GLUCOSAMINE TAB 250 MG - HEXPHARM JAYA No. V S1-0-0 -,Rute: Oral Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko - Malang. Telp. 0341-458679, 458918, Fax: 0341-441874, website: www.rs-primahusada.com Email: info@rs-primahusada.com Tindakan : Indikasi Dirujuk : nyeri bahu kanan sulit digerakkan ke atas mul - muntah - nyeri kepala - Diagnosis Rujukan : Adhesive capsulitis of shoulder Rencana Kontrol : Jumat / Tgl. 27-12-2024 Jam 15:30 WIB. DPJP : dr. Akhmad Syahrir Sp. N Mohon konsultasi/ penatalaksanaan dan Informasi edukas selanjutnya untuk pasien tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih Malang, 22-12-2024 Hormat saya, dr. Eko Nugroho Sp. KFR Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko - Malang. Telp. 0341-458679, 458918, Fax: 0341-441874, website: www.rs-primahusada.com Email: info@rs-primahusada.com
	PIC : DPJP dan Karu Irja
	Rencana Tindak Lanjut



	1) Pasien anak yang dirujuk dengan speech delayed dari FKTP ke SpA, maka SpA menjembatani rujuk internal ke rehab medik dan tidak lagi kontrol ke anak hingga program rehab / terapi wicara selesai. Apabila, pasien tsb ada keluhan, maka ditangani di FKTP 2) Pasien CVA rutin kontrol ke saraf yang perlu fisioterapi, maka dapat dilakukan ITER atau jika sudah stabil maka di PRB (sesuai dengan contoh diatas)
3	Pokok Bahasan : 9 diagnosis PRB
	• Masalah : 1. DM 2. Hipertensi 3. Jantung 4. Asma 5. PPOK 6. Epilepsi 7. Skizofrenia 8. Stroke 9. SLE 9 diagnosa diatas termasuk diagnosis wajib PRB , apabila ada tagihan rawat jalan dengan salah satu diagnosis diatas dan terapinya sama, maka potensi pending
	Keterangan : diagnosis PRB
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Jika ada kondisi medis yang menyebabkan pasien belum dapat di PRB kan dan masih harus control berulang, maka ditulis dengan jelas di rekam medis (diagnosa sekunder). Contoh: DM dengan Polineuropati / retinopati dsb.
4	Pokok Bahasan : Iterisasi obat
	Masalah : Meningkatkan pasien yang diiter untuk mengurangi angka kunjungan kronis yang berulang dan untuk pasien yang belum bisa di PRB
	Keterangan : Pasien kronis dengan iter
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Tingkatkan kunjungan pasien iter
5	Pokok Bahasan : STT
	Masalah : beberapa kasus STT yang pending
	Keterangan : kasus STT harus sesuai dengan BA BPJS terbaru
	PIC : DPJP operator
	Rencana Tindak Lanjut 1. Memastikan semua tindakan eksisi STT di rawat inap (dengan GA), sesuai dengan kriteria di bawah ini. 2. Dapat dilakukan FNAB terlebih dahulu di rawat jalan, untuk memastikan STT benign/malignant
6	Pokok Bahasan : IGD
	Masalah : pendingan IGD terkait pasien rawat inap yang di klaim rawat jalan oleh bpjs karena tidak ada visite dpjp
	Keterangan : klaim rawat inap
	PIC : DPJP dan Asuransi center



Matriks Ketentuan Penjaminan dan Penagihan Klaim IGD

No	Aspek Regulasi	Dijamin RITL	Dijamin RJTL	Tidak Dijamin	Berkas Verifikasi	Acuan Regulasi
1	Memenuhi salah satu kriteria Gawat Darurat: a. Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan; b. Adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi; c. Adanya penurunan kesadaran d. Adanya gangguan hemodinamik; dan/ atau e. Memerlukan tindakan segera	+	+	-	a. Resume Medis oleh DPJP b. Lembar triase ABC c. GCS s8 d. Vital Sign e. Tindakan segera pada kasus trauma	1. Perpres 82/2018; 2. Permenkes 47 Tahun 2018; 3. PNPK/Pedoman yang berlaku; 4. KepmenkesNo HK.01.07/MENKES/1541/2022
2	Perawatan IGD yang diberikan RS dilakukan sampai tuntas. a. Tidak dirujuk b. Dirujuk Note : telah mendapatkan tatalaksana sesuai indikasi medis sampai tuntas	+ - -	+/- +/-	-		PKS atau PNPK atau Pedoman yang berlaku
3	Telah Stabil Menunggu dirujuk	-	+	-		PKS atau PNPK atau Pedoman yang berlaku
4	Pelayanan yang diberikan di IGD > 6 Jam	+	+/-	-	Asuhan Keperawatan di IGD	Permenkes 26 Tahun 2021 tentang INA CBG
5	Mendapatkan tatalaksana rawat inap	+	-	-		
6	Memenuhi administrasi rawat inap	+	-	-		
7	Memenuhi indikasi medis Rawat Inap Telah menempati ruang perawatan, dan telah mendapatkan visitasi dari dokter spesialis yang merawat (DPJP)	+	-	-	Resume Medis oleh DPJP	PMK 26/2021; PNPK dan/ Pedoman yang berlaku
8	Keterangan: Kategori Ruang rawat inap sesuai Permenkes 40 Tahun 2022	+	-	-		Perpres No 82 Tahun 2018; Permenkes 28 Tahun 2014

Keterangan membaca matriks (matriks dibaca dari atas kebawah) :

1. Kasus IGD dijamin sebagai rawat inap apabila memenuhi salah satu kriteria gawat darurat. Perawatan IGD yang diberikan RS sampai tuntas dan tidak dirujuk. Pelayanan IGD diberikan lebih dari 6 jam, memenuhi indikasi rawat inap serta mendapatkan tatalaksana rawat inap, telah memenuhi administrasi rawat inap, serta menempati ruang perawatan dan mendapatkan visitasi dari dokter spesialis yang merawat (DPJP).
2. Kasus IGD dijamin sebagai rawat jalan apabila memenuhi salah satu kriteria gawat darurat. Perawatan IGD yang diberikan RS dilakukan sampai tuntas baik dirujuk maupun tidak dirujuk. Pelayanan dapat diberikan lebih dari 6 jam. Kasus IGD tidak dijamin apabila tidak memenuhi salah satu kriteria gawat darurat.

Rencana Tindak Lanjut

- Memastikan pasien yang dirujuk sudah mendapatkan tatalaksana rawat inap dan sesuai indikasi RI
- Mengusahakan untuk melakukan visite pasien sebelum dirujuk

7 Pokok Bahasan : Aplikasi HFIS 6.0

Masalah : Jadwal praktek dokter harian harus berbeda dengan jadwal visite dan jadwal ooperasi elektif

Keterangan : HFIS

PIC : DPJP dan kapid yanmed

- Penyesuaian menu atau fitur pada Aplikasi H.F.I.S versi 6.0, meliputi :
 - Penyesuaian Menu Waktu Pelayanan
 - Fitur Jadwal Praktik menjadi Jadwal Operasional
Terdapat perubahan nomenklatur pada fitur tersebut menjadi Jadwal Operasional. Jadwal operasional untuk mengakomodir waktu buka hingga tutup dari Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 - Fitur Jadwal Dokter menjadi Jam Kerja
Terdapat perubahan nomenklatur pada fitur jadwal dokter menjadi jam kerja, fitur ini untuk mengakomodir penjadwalan Jam Kerja bagi tenaga kesehatan. Jam kerja adalah periode waktu dimana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan di Fasilitas Kesehatan, baik fungsi pelayanan klinis kepada pasien maupun fungsi lainnya.
 - Penambahan Fitur Jadwal Praktik
Fitur ini untuk mengakomodir pencatatan waktu atau jadwal tenaga kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien di ruang poli. Fitur ini akan memberikan informasi ke Kapasitas Layanan yang dapat dibaca pada Aplikasi Antrean Online, sehingga mendapatkan gambaran kapasitas yang lebih tepat. Pada saat fitur tersebut diimplementasikan, data yang terdapat pada Jadwal Praktik secara otomatis akan terisi sama dengan data Jam Kerja dan data jadwal praktik tervalidasi dalam cakupan/tidak melebihi Jam Kerja.
 - Penambahan Jadwal Praktik Pada Poli Eksekutif
Fitur ini melekat pada Dokter Spesialis/SubSpesialis di Rumah Sakit, dimana jadwal Praktik Poli Eksekutif tidak dapat beririsan dengan jadwal Praktik Non Poli Eksekutif.
 - Penyesuaian Fitur Kapasitas Layanan FKRTL
Penyesuaian fitur tersebut, membagi kapasitas layanan menjadi Pagi dan Sore berdasarkan data Jadwal Praktik. Pagi hari dimulai sejak pukul 07.00 s.d 14.00 dan Sore hari dimulai sejak pukul 14.00 s.d 21.00.

Rencana Tindak Lanjut

Mengidentifikasi DPJP agar segera mengisi form dengan format terbaru 3 HFIS (praktek, visite, operasi)

8 Pokok Bahasan : Visite pasien bedah

Masalah : adanya komplain dari pasien yang tidak divisite selama di rawat inap post operasi

Keterangan : visite di rawat inap

PIC : DPJP



	Rencana Tindak Lanjut DPJP di Himbau sesuai dengan kebijakan dari PT terkait visite pasien operasi, dilakukan pre dan post operasi (rawat inap)
No	Penjelasan
9	Pokok Bahasan : LOS < 3 hari
	Masalah : adanya pending BPJS atas pasien yang rawat inap hanya 2 hari. Konfirmasi BPJS: LOS <3 hari, tidak ada indikasi rawat inap.
	Keterangan : klaim bpjs
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut 1. Himbauan: memastikan indikasi rawat inap pasien dan memastikan pasien KRS sesuai indikasi / kriteria PNPK (min. 3 hari RI) 2. Untuk pasien post OP → di lakukan KRS pasien minimal 24 jam post OP
10	Pokok Bahasan : Injeksi intraartikular dan fisioterapi
	Masalah : • Injeksi intraarticular dan fisioterapi • Himbauan: memastikan semua tindakan yang dilakukan sudah sesuai indikasi dan sesuai dengan PNPK. Karena semua tindakan dengan pembiayaan tinggi akan menarik perhatian BPJS
	Keterangan : pembiayaan tinggi
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Memastikan semua tindakan yang dilakukan sudah sesuai indikasi dan sesuai dengan PNPK. Karena semua tindakan dengan pembiayaan tinggi akan menarik perhatian BPJS
11	Pokok Bahasan : Kunjungan berpola
	Masalah : Kunjungan berpola pasien poli peny dalam = Kunjungan ber Pola ex: <pre>graph LR; A[Kunjungan 1 Pasien Lab] --> B[Kunjungan 2 Pasien Injeksi Intra Articular]; B --> C[Kunjungan 3 Pasien dapat obat];</pre>
	Keterangan : Potensi pending bpjs
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Pasien dirawat sesuai dengan indikasi, dan tidak ada sistem berpola, sehingga tidak menyebabkan tren kunjungan berulang yang berpotensi pending bpjs
12	Pokok Bahasan : Fragmentasi
	Masalah : Terdapat lonjakan terkait pending rawat jalan dengan kasus Potensi fragmentasi Bulan Oktober = 331 kasus, Bulan November = 641 kasus
	Keterangan : Fragmentasi
	PIC : DPJP
	Rencana Tindak Lanjut Pasien yang mendapatkan resep obat 30 hari maka pasien di terbitkan jadwal surat kontrol sesuai dengan obat habis, tidak dikunjungi berulang dalam satu bulan

BED	57	PAR	11
ANA	52	SAR	10
JIW	48	JAN	8
MAT	40	THT	7
INT	33	URO	7
KLT	20	IGD	4
OBG	17		
ORT	15		

Pemimpin Rapat
Ketua Komite Medik



dr. Arief heru Wicaksono, SpAn

Malang, 24 Desember 2024
Notulis



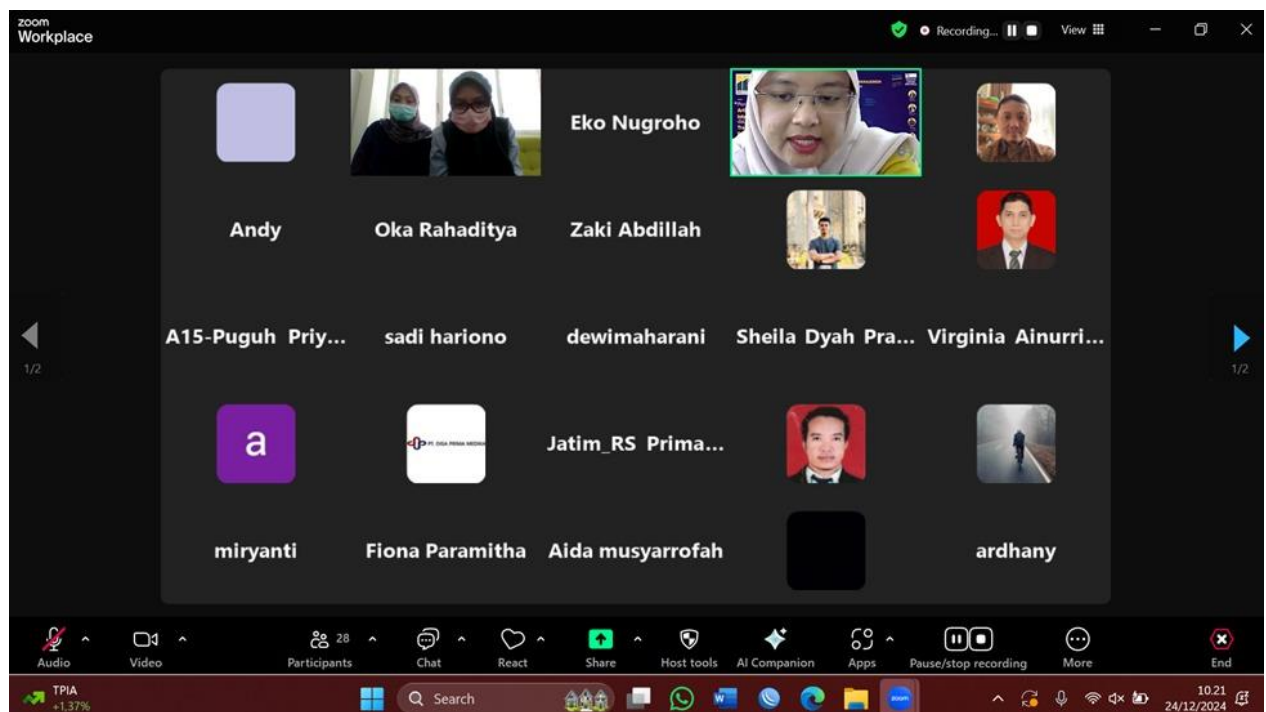
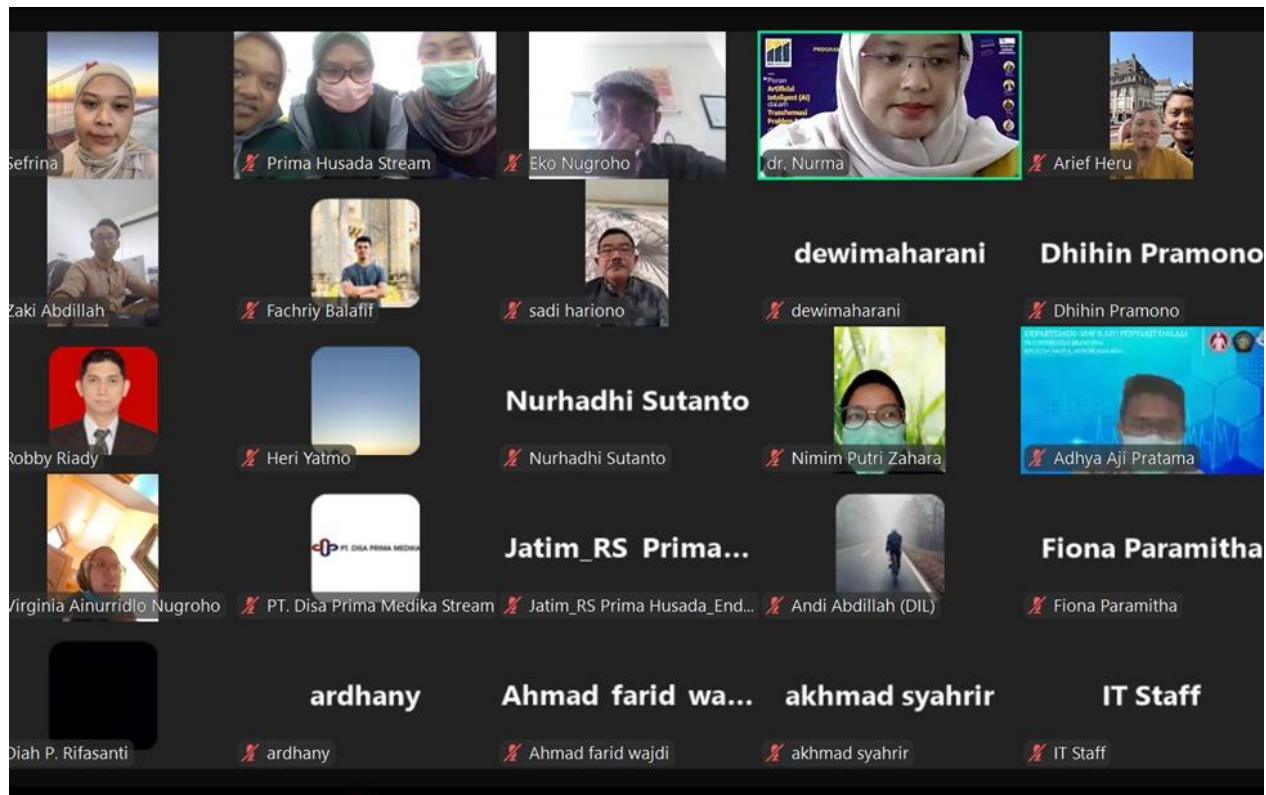
Puput Sekar Nariratih, Amd,Keb

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

DOKUMENTASI





RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: -

Tanggal dan : Selasa, 2024-12-24 10:00:00

Jam Tue, 2024-12-24 10:00:00

Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Mahesa Yudistiranti, S.AP		administrasi	
2	dr Diah Puspita Rifasanti, Sp.M	Poli Mata	Dokter	
3	dr. Eko Nugroho, Sp. KFR	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	
4	dr. Fiona Paramitha, Sp.A	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Anak	
5	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Anak	Dicky
6	dr. Dicky Faturrachman, Sp. A	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Anak	Dicky
7	dr. Miryanti Cahyaningtias, Sp. JP	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Jantung Pembuluh Darah	
8	dr. Nurhadhi Sutanto, Sp. M	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Mata	Nurhadhi
9	dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	
10	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi	
11	dr. Andy. Sp.P	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan	Andy
12	dr. Agung Setyawan Sp.Rad	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Radiologi	
13	dr. Dewi Maharani, Sp. S	RS Prima Husada Malang	Dokter Spesialis Saraf	
14	dr Wiryantari Akhdani Pratiwi	Manajemen	Kabid yanmend	Wiryantari Akhdani Pratiwi
15	dr. Arief Heru Wicaksono SpAn TI	RSPH	Kakomed Prima Husada Malang	



RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: -

Tanggal dan : Selasa, 2024-12-24 10:00:00

Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
16	Rossy zaki abdillah	RSPHSKR	Kepala Instalasi Rawat Jalan RSPH Sukorejo		
17	Puput Sekar Nari Ratih,AMd. Keb.SE	RSPHMLG	Kepala Ruang Rawat Jalan RSPH Malang		
18	dr.Ahmad Farid Wajdi.SpN	Phm	Neuro		
19	dr. Adhya Aji	Spv IGD RSPHM	PESERTA		
20	dr. Sheila Dyah Prasetyo	Dokter ruangan	PESERTA		
21	dr. Robby, Sp-An-TI	Anestesi	PESERTA		
22	dr.Humaira,SpOg	Maternitas	PESERTA		
23	dr. Fachriy Balafif SpBS	Bedah saraf	PESERTA		
24	dr. Meyrna Heryaning Putri, ,Sp.THT	PT Disa Prima Medika	PESERTA		
25	dr. Zoraida Dwi Wahyuni, SpPD	IPD	PESERTA		
26	Dr. Dwi Nurwulan Pravitasari, Sp.KK	Poli	PESERTA		
27	dr.Virginia Ainurridlo Nugroho SpKFR	Rehab Medik	PESERTA		
28	dr. Andi Abdillah SpB FINACS	Bedah	PESERTA		
29	Drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS	Manajemen	PESERTA		
30	Drg. Endy Wira Pradana.,M.MRS	Manajemen	PESERTA		



RSPHMLG
RS PRIMA HUSADA MALANG, SINGOSARI - MALANG
RS PRIMA HUSADA MALANG

Daftar Hadir
Rapat Komite Medik

Tempat
Location

: -

Tanggal dan : Selasa, 2024-12-24 10:00:00

Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
31	dr. Akhmad Syahrir Sp.N	KSM Neuro	PESERTA		
32	dr. Ardityo Rahmat Ardhany, SpPD-KGH	IPD	PESERTA		
33	dr. Antonius Setiadi, SpB	SMF Bedah	PESERTA		
34	dr. Nur Mazidah	RSPHMLG	PLT Direktur RS Prima Husada Malang		Nur Mazidah

Malang, 03 Januari 2025

mahesayudistiranti@gmail.com